Algoritmo CIF — Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Lumbar. Las hipótesis se acumulan: cada respuesta puede sumar una y el recorrido sigue hasta el último paso.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

PASO 1 — EVALUACIÓN DE DOLOR IRRADIADO (RAMA RADICULAR)

¿El dolor baja por la pierna (unilateral) y es peor que el dolor de espalda?

- **SÍ** — SLR positivo <60°, Test de Slump positivo o déficits neurológicos dermatomales → sin hipótesis
- **NO** — Sin irradiación predominante a la pierna → **Paso 2** → sin hipótesis

▼

Desvío: solo si se llega desde Paso 1 «SÍ»

PASO 1B — SUB-DECISIÓN RADICULAR

¿El dolor CENTRALIZA con movimientos repetidos (Método McKenzie/MDT)?

- **SÍ** — El dolor centraliza (mejor pronóstico) → ③ **Dolor Radicular Lumbar**
- **NO** — No centraliza o periferaliza → ③ **Dolor Radicular Lumbar**

▼

Desvío: solo si se llega desde Paso 1b (cualquier respuesta)

PASO 1C — DÉFICIT NEUROLÓGICO (RADICULOPATÍA)

¿Hay déficit de fuerza, sensibilidad o reflejos en la pierna (comparado con el lado sano)?

- **SÍ** — Debilidad en un miotoma, reflejo disminuido o alteración sensitiva dermatomal → ⑤ **Radiculopatía Lumbar (Déficit Neurológico)**
- **NO** — Exploración neurológica normal → sin hipótesis

▼

PASO 2 — EVALUACIÓN POR EDAD Y POSICIÓN (RAMA ESTENOSIS)

¿El paciente es mayor y el dolor mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante?

- **SÍ** — Dolor bilateral en glúteos/muslos, alivio con "signo del carrito de compras" → ④ **Estenosis Espinal / Claudicación Neurogénica**
- **NO** — Sin este patrón → sin hipótesis
- **VASCULAR** — Los síntomas al caminar ceden con solo pararse de pie, sin sentarse ni flexionar: sospecha de claudicación vascular → derivación médica → 🩺 **Derivación médica — el árbol continúa**

▼

PASO 3 — EVALUACIÓN MECÁNICA Y CRONOLOGÍA

¿Cómo es el patrón de dolor lumbar predominante?

- **Agudo/Rigidez** — Síntomas <16 días, sin dolor bajo la rodilla y restricción segmentaria hipomóvil → ① **Disfunción Segmentaria Lumbosacra (Déficit de Movilidad)**
- **Persistente/Inestabilidad** — Dolor en rangos finales o posturas sostenidas con sensación de "fallo" → ② **Inestabilidad Espinal Lumbar (Déficit de Coordinación)**
- **Ninguno de los dos** — Continuar con el patrón de dolor inespecífico → sin hipótesis

▼

PASO 4 — DOLOR INESPECÍFICO: PATRÓN PREDOMINANTE

¿Qué patrón encaja mejor? (Revisar siempre cadera y factores contribuyentes.)

- **DISCOGÉNICO** — Dolor en línea media + preferencia direccional o centralización con movimientos repetidos; puede cambiar de lado → ⑥ **Dolor Lumbar Discogénico**
- **FACETARIO** — Paramedial unilateral, dolor en extensión o extensión + rotación, sin pasar de la rodilla; los repetidos no alivian → ⑦ **Dolor Lumbar Facetario**
- **SACROILÍACA** — Dolor en zona de Fortin sin dolor en Tuber, no centraliza → ⑧ **Dolor de la Articulación Sacroilíaca**
- **MIOFASCIAL** — Banda tensa palpable + punto hipersensible + el paciente reconoce el dolor provocado → ⑨ **Síndrome de Dolor Miofascial Lumbar**
- **NINGUNO** — Sin patrón predominante → sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa: la app propone trabajar con «dolor de lumbar inespecífico», revisar los factores psicosociales y reconsiderar las respuestas; si el cuadro es crónico con riesgo psicosocial alto, considerar también sensibilización central.

Fase 4b: confirmar cada hipótesis activa con sus tests (esquema de confirmación de lumbar).

Generado desde los datos de la app el 4/10/2026.